UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

MIR
Hypokaliémie sans patient & sans geste clinique

Nom du rédacteur : MAKLARY Rosalie **Date de rédaction : 04/12**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N°201– Dyskaliémie

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Urgence

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Stratégie de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1- Identifier les signes électrocardiographiques de dyskaliémie et reconnaître les signes de gravité.

2- Initier la prise en charge thérapeutique dans les situations urgentes et orienter la prise en charge en unité adaptée.

Objectifs de la station (items de connaissances abordés) :

1- Item 231 : électrocardiogramme – indications et interprétations

2- Item 267 – troubles de l'équilibre acido-basique et désordres hydro-électrolytiques

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- 1 table, 2 chaises, ECG imprimé, ionogramme imprimé (ci-dessous).

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne aux urgences. Vous êtes appelé par un collègue en cabinet de médecine générale pour un électrocardiogramme anormal sur patient inconscient. Votre collègue vous raconte que le patient est venu, il y a 2 semaines, pour un bilan de contrôle ayant montré l'ECG n°1, qu'il vous transmet. A la suite duquel, un bilan biologique et une visite de contrôle avait été prescrit.
Le patient a pour seul antécédent une anxiété aigue traitée par Citalopram

Alors que le patient était dans la salle d'attente, il a perdu connaissance. L'ECG n°2, réalisé après la perte de connaissance vous est transmis

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Analyser les électrocardiogrammes, donner le diagnostic électrocardiographique
2. Analyser le bilan biologique fourni et énoncer la ou les anomalies biologiques
3. Enoncer la prise en charge en urgence de l'anomalie électrocardiographique et de l'anomalie biologique.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Énonce la présence d'un espace QT long sur l'ECG	
Enonce des ondes T négatives sur l'ECG n°1	
Énonce la présence de complexes QRS avec inversion régulière de l'axe	
Énonce la présence d'une torsade de pointe sur l'ECG n°2	
Tache 2	
Enonce la normalité du reste du bilan	
Enonce l'hypokaliémie	
Tache 3	
Propose une surveillance cardiaque scopée	
Enonce la mise en place d'une réanimation cardiopulmonaire	
Énonce l'arrêt de tout traitement allongeant le segment QT	
Propose la réalisation d'un choc électrique externe	
Propose une perfusion de sulfate de magnésium IV (*pour la torsade de pointe*)	
Propose une perfusion de chlorure de potassium KCl par voie IV (*pour l'hypokaliémie)*	
Propose une perfusion d'ISOPRENALINE si FC <70bpm *(accélération du cœur pour diminuer artificiellement l'espace QT)*	
Énonce le transfert : - Médicalisé - pour prise en charge en unité de soins intensifs général ou USIC	
COMPETENCES GENERIQUES	
APTITUDE A FAIRE LA SYNTHESE DES DONNEES	
APTITUDE A PROPOSER UNE PRISE CHARGE D'UNE SITUATION AIGUË	
Note totale	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Cocher si fait
Tache 1	
Énonce la présence d'un espace QT long sur l'ECG	
Enonce des ondes T négatives sur l'ECG n°1	
Énonce la présence de complexes QRS avec inversion régulière de l'axe	
Énonce la présence d'une torsade de pointe sur l'ECG n°2	
Tache 2	
Enonce la normalité du reste du bilan	
Enonce l'hypokaliémie	
Tache 3	
Propose une surveillance cardiaque scopée	2
Enonce la mise en place d'une réanimation cardiopulmonaire	1
Énonce l'arrêt de tout traitement allongeant le segment QT	2
Propose la réalisation d'un choc électrique externe en cas de	4
Propose une perfusion de sulfate de magnésium IV (*pour la torsade de pointe*)	5
Propose une perfusion de chlorure de potassium KCl par voie IV (*pour l'hypokaliémie)*	5
Propose une perfusion d'ISOPRENALINE si FC <70bpm	3
Énonce le transfert : - Médicalisé pour prise en charge en unité de soins intensifs général ou USIC	2
COMPETENCES GENERIQUES	
APTITUDE A FAIRE LA SYNTHESE DES DONNEES	1 à 5
APTITUDE A PROPOSER UNE PRISE CHARGE D'UNE SITUATION AIGUË	1 à 5
Note totale	Note /50